HLB 테라퓨틱스

Investor Relations

Disclaimer

免責告知

1. 本資料は情報提供目的で作成されたものであり、投資勧誘または請約の提案ではない
2. 本資料の未来に関する叙述は、作成日現在の計画と判断に基づいたもので、実際の結果と異なる場合がある
3. 本資料の臨床および許可日程は規制機関の審査結果と試験進行状況によって変更されることがある
4. 本資料の内容は別途の告知なしに変更されることがあり、当社はこれを更新する義務を負わない

核心要約

HLB 테라퓨틱스

NK[1] 治療薬 RGN-259 の米国臨床 3 相トップライン 2026 年 11 月発表
臨床結果を確認した後、グローバルビッグファーマライセンスディールを推進

投資ポイント

- **臨床結果発表間近**
  2026 年 11 月、米国臨床 3 相トップラインの結果を公開予定
- **グローバル・ビッグファーマ・ライセンス・ディール**
  欧州臨床以降も米国の臨床成果に対する関心を基に協力関係を持続
- **パイプライン拡張**
  角膜輪部幹細胞欠乏症 (LSCD) による適応症開発推進 (非臨床進行中)
- **独自の現金創出基盤の強化**
  新薬開発資金の外部調達を最小化するため、コールドチェーン事業部をキャッシュカウに強化

コア指標

2026 年 11 月	**$1.7B / CAGR 39%[2)]**	**患者の利便性**	**588 億ウォン**
SEER-2 トップライン結果発表	NK 唯一の許可競争薬物、 2025 年に売上 / 「 21~25 年の年平均成長率」	使い捨てバイアル / 常温保管 /4 週間治療	コールドチェーン事業部 2025 年売上 (前年比 +28.1%)

1) Neurotrophic Keratitis(神経栄養性角膜炎): 角膜神経損傷により角膜が自ら治癒されず失明に至ることがある希少眼疾患
2) □□ : Chamber of Commerce of MILAN MONZA BRIANZA LODI; Business Register - Official archive of the Chamber of Commerce

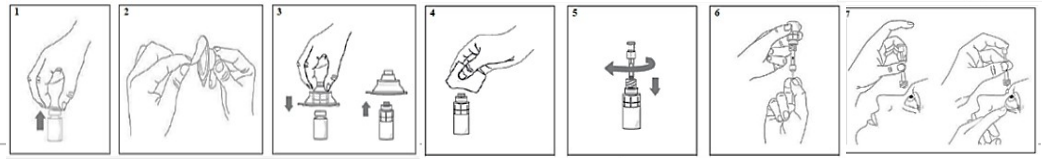
事業別成長ロードマップ

	顕在 **2025~2026** 年	核心前提条件 次の段階への進入条件	未来 **2027** 年 ~
眼科新薬 **RGN-259 (NK)**	米国臨床 **3** 相完了 2026.8 月	トップライン結果発表 **(2026.11** 月 **)** **FDA** タイプ **C** ミーティング **(2027.2** 四半期 **)**	グローバルビッグファーマライセンスディールなどを推進 **2027.3Q** 目標
適応症拡張 **LSCD**[1] など	非臨床有効性探索進行	非臨床有効性データの確保	**NK·LSCD** パッケージでディール規模拡大
コールドチェーン事業 バイオ医薬品流通	売上高 **588** 億ウォン 2025 年、 +28.1% YoY	新型コロナウイルス感染症の公共ワクチンの **3** 年間の独占供給で検証された **SOP** 基盤の核心顧客企業の追加確保	市場シェアの拡大による キャッシュカウ強化

成長の分岐点 I 2026 年 11 月 RGN-259 アメリカ臨床 3 相トップライン発表

1) Limbal Stem Cell Deficiency(潤部幹細胞欠乏症): 角膜縁 (潤部) の幹細胞が損傷し、角膜表面が再生されず視力低下 · 失明につながる可能性のある希少眼疾患

既存の治療薬に比べ競争優位

	RGN-259	オクサーベイト (イタリア · ドンペ社)
有効成分	チモシンベータ 4 （ Tβ4 ） • 人体のすべての組織と涙に自然に存在する物質 • 天然物質のような構造の合成医薬品で大量生産が容易	組換え人間神経成長因子 (rhNGF) • 眼球表面に存在する天然物質 • 大腸菌を培養して生産するバイオ医薬品
作用機転	• 上皮再生・神経再生・抗炎症が一緒に働く多重作用機転 • 持続性上皮欠損 (PED) を素早く回復	• 神経成長因子として角膜神経機能と上皮細胞の生存を補助
投与方法及び治療期間	• 1 日 5 回点眼 • **4** 週間治療 : 急速な欠損回復により感染 · 病変悪化のリスクが減少	• 2 時間間隔 1 日 6 回 点眼 • 八週間治療
安全性及び耐弱性	• プラセボと同等の安全性及び耐薬性	• 患者の 16% から眼球の痛み
保管条件	予想条件 • 流通 : 冷蔵 （ 2~8℃ ） • 患者 :4 週間の治療期間中、常温保管可能	週間包装単位 （ 7 バイアル ） • 薬局 : 冷凍 （ -20℃±5℃ ） • 患者 : 冷蔵または 25℃ 以下、 12 時間以内に使用
パッケージ	• 使い捨てバイアルで使いやすい 	• 1 日分 多回用バイアル (アダプター · スポイトなど別途道具必要) 

被験者割り当て状況の比較

Parameter	SEER-2(米国)	SEER-3 (ヨーロッパ)
スクリーニング（Screened)	106	88
スクリーニング脱落 **(Screen Failure)**	(*)	(*)
ランダム割り当て (Randomized)	70	79
臨床薬未投与 (Not Dosed with Masked Study Medication)	0	1
臨床薬投与（Dosed with Masked Study Medication (mITT))	70	78
臨床中断患者 **(Patients Discontinued from the Study)**	(*)	(*)
臨床完了患者 (Patients Completed Study)	(*)	(*)
mITT 分析患者数（Number of Patients in mITT)	**70**	**78**
ITT 分析患者数（Number of Patients in ITT)	**67**	**65**
4 週間投与完了以前の早期中断 **(Early Termination before 29 days)**	(*)	(*)
角膜写真不良により等級評価不可 **(Cannot Grade)**	(*)	(*)

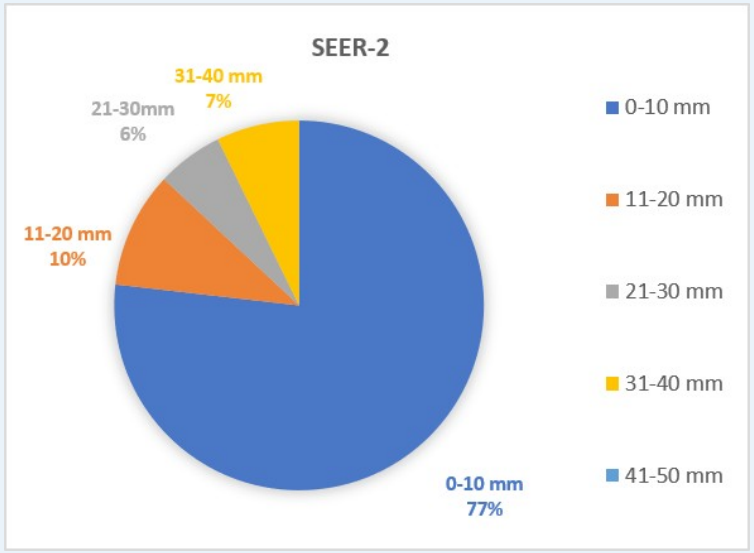
(*) 臨床データ分析中の事項であり、公開範囲から除外

Part 2. RGN-259

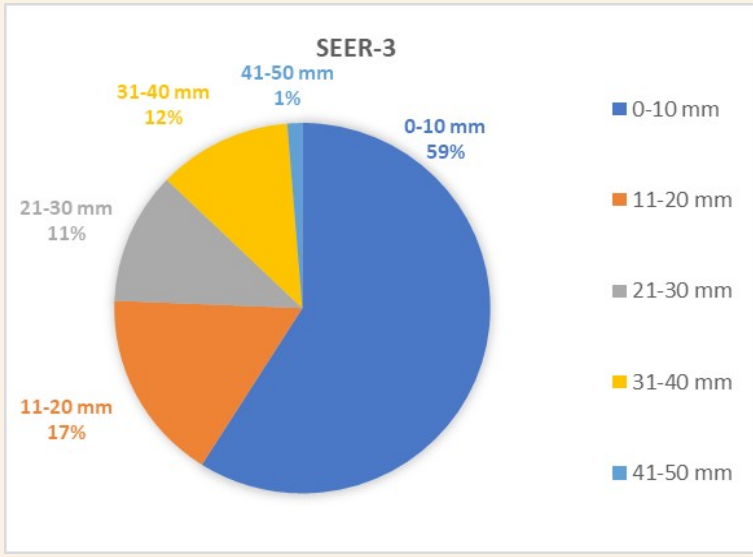
臨床患者基礎特性の比較

角膜知覚度比較 (Corneal Sensitivity)[1)]

● **SEER-2** 重症度の高い 0~10mm の患者群が 77% 布陣 - 疾患特性が



● **SEER-3** 0~10mm の患者群が 59% で相対的に少ない - 軽症・類似患者混在



緑内障 (Glaucoma) の同伴患者の完治率 (CORC 基準)

52%

SEER-2

使い捨て点眼剤を使用して **RGN-259** 薬効を完全に維持

vs

25%

SEER-3

保存剤を含む多回用製剤による **RGN-259** 薬効阻害推定

数値が低いほど角膜神経損傷が激しい重症患者を意味

※ 上記の分析は、二重盲検が維持された状態で確保したデータに基づく判断である

欧米臨床分析の示唆点

SEER-2（米国臨床 3 相）「成功期待要因」

- **重症患者集中**
  厳格なスクリーニングで疾患特性が明確な重症患者中心の登録
- **低い離脱率**
  臨床中断患者の割合が低く、データ信頼度を確保
- **治療前の患者の状態の小さな変動性**
  角膜知覚度基準重症患者の割合が高い（疾患特性明確）
- **緑内障患者の完治率が相対的に高い**
  患者が使い捨て（無保存剤）緑内障の目薬を使用し、 RGN-259 の薬効を維持

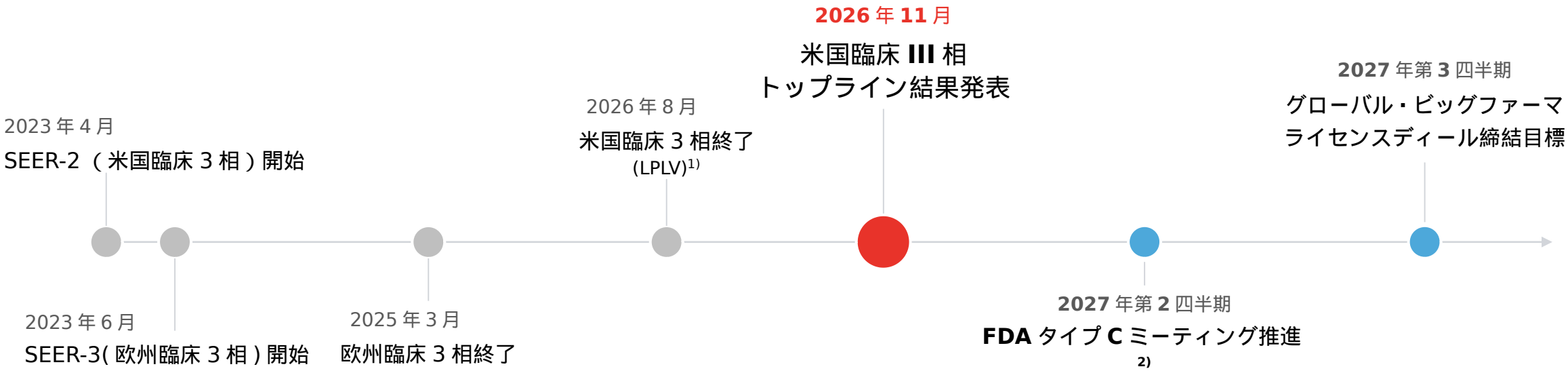
SEER-3(欧州臨床 3 相)「胃薬群の高い完治率の原因分析」

- **患者群異質性**
  低いスクリーニング脱落率で類似症状患者が多数流入
- **高い離脱率**
  相対的に高い臨床中断患者の割合でデータノイズ発生
- **治療前の患者の状態の大きな変動性**
  角膜知覚度基準 重症患者群が相対的に少ない（軽症・類似患者混在）
- **緑内障患者の完治率が比較的低い**
  患者が保存剤配合の緑内障目薬を使用し、 RGN-259 薬効阻害推定

※ 上記の分析は、二重盲検が維持された状態で確保したデータに基づく判断である

Part 2. RGN-259

主なマイルストーン
（ 2026~2027 ）

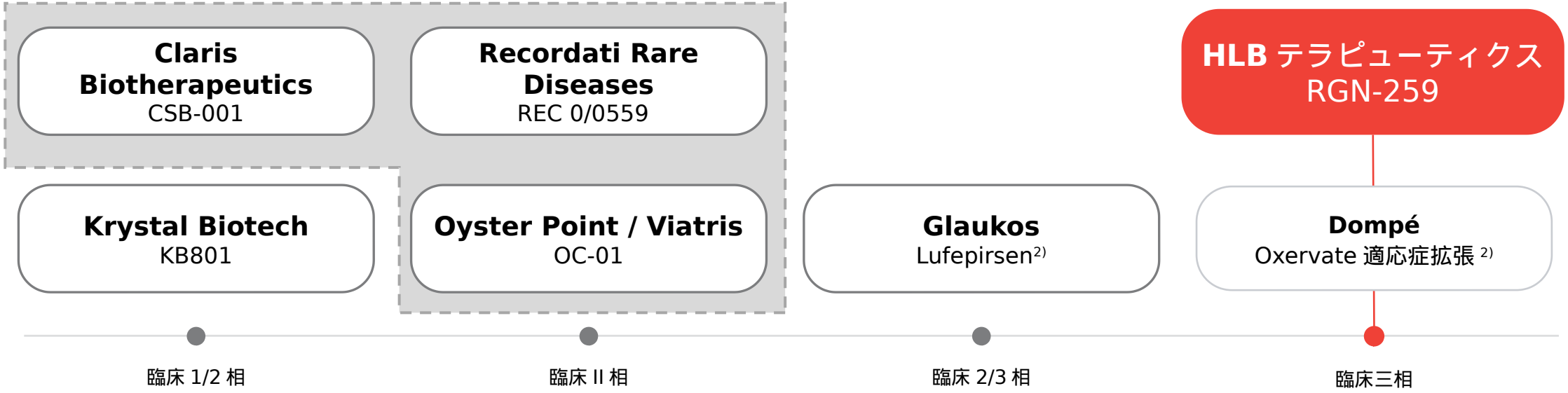


1) LPLV(Last Patient Last Visit): 最後の登録患者の臨床機関訪問終了

2) 追加臨床短縮の可能性など議論目標
※ 2026 年 11 月のトップライン以降の日程は SEER-2 臨床結果の成功を前提とした計画であり、今後の進行状況によって変更される可能性がある

NK 治療剤競争臨床現況 (2026 年 9 月基準)

1 次評価指標未充足または開発戦略変更により NK 適応症後続開発が確認されない [1)]



RGN-259 競争優位戦略

→ 投与の利便性と薬価の競争優位で市場シェアを確保
→ 角膜輪部幹細胞欠乏症 (LSCD) など適応症拡張

1) Claris: 臨床 1/2 相 1 次評価指標未達成後、 LSCD に適応症転換 / Recordati, Oyster Point·Viatris: 臨床 2 相終了後、 NK 後続臨床未登録 (2026 年 9 月、 ClinicalTrials.gov 及び各社発表基準)
2) PCED(持続的角膜上皮欠損) を対象とする臨床で、当社の NK 臨床と適応症は異なるが、治療目標が一部重なる

パイプライン拡張戦略

膠芽腫 (GBM) 治療薬

臨床 II 相

OKN-007(当社候補物質、 FDA 希少医薬品指定)

未充足需要

約 20 年間続いた TMZ 中心の標準治療、生存期間改善のための新しい治療オプションに対する高い需要

予想市場規模

主要 7 カ国 (米国、 EU4 、英国、日本) 基準

2025 年 $0.9B → 2036 年 $4.8B 成長見通し [1)]

開発段階

再発患者対象の 2 相完了 (OKN-007+TMZ)

新規患者対象の研究者臨床 1 相実施 (OKN-007+ 放射線 +TMZ)

→ 自己中間分析の結果、目標生存率達成、
TMZ を含む他臨床の historical data に対する優位確認

黄斑変性 (w-AMD) 治療薬

導入検討 3)

既存の注射剤に比べて患者の利便性が高い点眼剤

未充足需要

反復投与と病院訪問の負担を低くした次世代 w-AMD 治療オプションに対する高い需要

予想市場規模

主要 7 カ国 (米国、 EU4 、英国、日本) 基準

2025 年 $10.1B → 2036 年 $19.3B 成長見通し [2)]

開発段階

動物モデル非臨床有効性探索進行中

視神経炎遺伝子治療薬

導入検討 3)

AAV ベースの網膜神経節細胞損失抑制遺伝子治療薬

未充足需要

許可された急性視神経炎治療薬なし

ターゲット疾患

視神経炎 4 タイプ

(特発性、多発性硬化症関連、視神経脊髄炎、 MOG 抗体関連)

緑内障による適応症拡張の可能性

(視神経炎、緑内障とも網膜神経節細胞損失により視力低下)

導入目標

初期の現金負担を最小限に抑えるライセンシングモデルの検討中

適応症拡張の可能性でグローバルビッグファーマパートナーシップを期待

単一パイプラインを越え、希少疾患治療剤の開発能力を備えた企業に跳躍

1) □□ : DelveInsight, 『 Glioblastoma Multiforme Market Insights, Epidemiology and Market Forecast – 2036 』 , 2026.
2) □□ : IMARC Group, 『 Wet Age-Related Macular Degeneration (Wet AMD) Market Size, Epidemiology, In-Market Drugs Sales, Pipeline Therapies, and Regional Outlook 2026–2036 』 , 2026.
3) 候補物質導入検討段階で契約締結可否 · 条件 · 時点は未確定

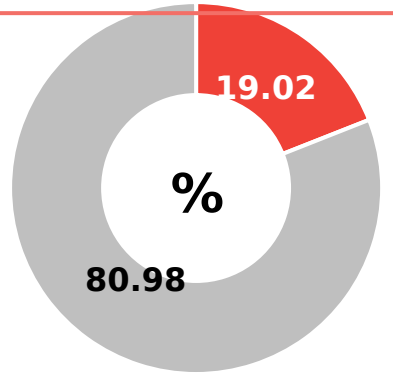
Appendix

会社概要

企業概要

会社名	HLB テラピューティクス株式会社
代表取締役	アン · ギホン
設立日 / 上場日	2000 年 6 月 7 日 /2010 年 3 月 26 日
役職員数	83 人 (本社 12 名 / コールドチェーン事業部 50 名 / ジートリファーマシュティカル 21 名)

株主現況



発行済株式総数
94,683,294 株

筆頭株主及び特殊関係人	19.02%
その他の株主	80.98%

最近 3 年間の財務の要約

連結基準 · 単位 : 億ウォン

	FY2023	FY2024	FY2025
売上	**526**	**549**	**696**
コールドチェーン事業部	435	459	588
電子事業部 1)	91	90	108
営業利益	**-87**	**-76**	**-35**
コールドチェーン事業部	42	65	58
電子事業部 1)	-6	-8	-5
本社及びバイオ事業部	-124	-133	-88
当期純利益	**-31**	**-235**	**-97**
研究開発費 (資産化)	**55**	**81**	**88**

1) 2025 年 1 月 1 日物的分割

Thank You

IR お問い合わせ

企画チームのイ · ミョンス次長
lms@hlbtherapeutics.com